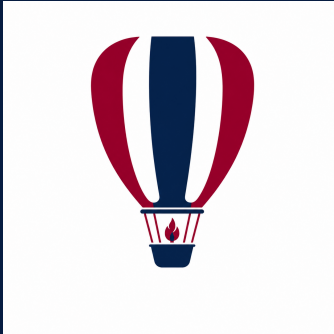


ШАРиК digital

Patient Flow Company для стоматологий



ICP ШАРиК digital

идеальный клиент для

Patient Flow System

Документ для outbound, CRM, квалификации, продаж и найма

Главная формула

Берём клиники, где уже есть поток, деньги, digital-точки и управленческая боль.

Не берём клиентов, которые хотят дешёвые задачи без диагностики и ответственности.

00 / EXECUTIVE SUMMARY

ICP как фильтр роста

ШАРiK digital не должен продавать всем стоматологиям подряд. Нам нужны клиники, где уже есть поток, деньги, digital-точки и управленческая боль: собственник видит, что пациенты интересуются клиникой, но не понимает, где они теряются до записи, лечения и возврата.

Главная логика ICP: клиника должна иметь не только проблему, но и способность купить систему её решения. Если у клиента нет бюджета, данных, ответственного лица и готовности менять процессы, он не подходит даже при красивой боли.

Берём

Клиники с 2-8 креслами, сайтом, картами, отзывами, администраторами, признаками patient flow-потерь и собственником, готовым говорить о цифрах.

Не берём

Клиники, которые ищут SMM подешевле, хотят гарантии без диагностики, не дают доступы, не готовы менять обработку и считают, что проблема всегда только в рекламе.

Критерий	Идеальное значение	Тревожный признак
Размер	Частная стоматология с 2-8 креслами	Микроклиника без потока или сеть без доступа к ЛПР
Digital-точки	Есть сайт, карты, отзывы, формы, мессенджеры, реклама или CRM	Нет базы для диагностики или всё скрыто
Боль	Пациенты теряются между интересом, записью, лечением и возвратом	Клиент просит только посты, рекламу или дешёвые лиды
Бюджет	Готов платить за систему 150-250 тыс. руб./мес после диагностики	Хочет "попробовать за 20-30 тыс."

01 / CORE ICP

Основной ICP

Идеальный клиент - это клиника, где patient flow уже существует, но не управляется. У неё есть точки контакта, обращения, пациенты, команда и деньги, но нет ясной картины: где именно люди выпадают из маршрута.

Параметр	Идеальный профиль
Размер клиники	Частная стоматология с 2-8 креслами. Достаточно большая, чтобы иметь поток, но ещё управляемая для быстрых изменений.
Стадия развития	Клиника уже работает, имеет базу пациентов, вложения в digital и желание расти. Не старт с нуля и не стагнация без бюджета.
Digital-инфраструктура	Есть сайт, карточки на картах, отзывы, формы связи, мессенджеры, телефон, администраторы. Желательно есть реклама и CRM.
Бюджет	Понимает, что управляемость потока стоит дороже отдельных задач. Потенциал: диагностика, стартовый проект, 90-дневный цикл.
ЛПР	Собственник, управляющий или директор, который влияет на деньги, процессы, администраторов, доступы и внедрение.
Цели владельца	Стабильный поток первичных пациентов, рост записей, снижение хаоса, контроль обработки, масштабирование без раздувания бюджета.

Ключевой вывод

ICP ШАРiK digital - это клиника, у которой есть что терять, есть чем платить и есть управленческая готовность чинить систему, а не покупать случайные digital-задачи.

02 / WHY THEY PAY

Почему именно эта ЦА способна платить

Частная стоматология платит не за "маркетинг". Она платит за снижение потерь в системе, которая влияет на деньги. Один первичный пациент может принести консультацию, план лечения, повторные визиты, семейные рекомендации и долгосрочный LTV.

- Высокая стоимость пациента: потеря одного первичного пациента часто дороже, чем выглядит на уровне заявки.
- Длинный путь доверия: пациент сравнивает врачей, отзывы, цены, сайт, карты и ответы администраторов.
- Много точек потерь: пациент может выпасть в картах, сайте, мессенджере, звонке, CRM, после "подумаю" или после первичного приёма.
- Рынок уже покупает digital: клиники готовы платить за инструменты, но им нужно переобъяснить покупку через управляемость потока.
- Собственник устал от хаоса: ему нужна ясность, где теряются люди и деньги.

03 / MICROSEGMENTS

Микросегменты внутри ICP

Микросегменты помогают строить outbound не по всем стоматологиям, а по видимым потерям. У каждого сегмента своя гипотеза, свой заход и свой следующий продукт.

Микросегмент	Что видно	Главная потеря	Первый продукт
Слабые карты	Низкий рейтинг, мало фото, нет ответов, устаревшие данные	Контакт + доверие	Patient Flow Check по картам
Устаревший сайт	Слабая мобильная версия, нет врачей, нет ясного СТА	Контекст + конверсия	Карта потерь пациентов
Реклама есть, записей мало	Есть трафик, но путь после клика слабый	Конверсия + коммуникация	Диагностика маршрута после заявки
Сильные врачи, слабая упаковка	Врачи есть, но ценность и доказательства не раскрыты	Кредит доверия + контекст	Модуль доверия и смысла
Плохая обработка заявок	Долгий ответ, нет скрипта, слабая фиксация статусов	Коммуникация	Аудит обработки + критические потери
Низкая доходимость	Записываются, но не приходят или часто переносят	Коммуникация + камбэк	Контур напоминаний и возврата
Нет повторных касаний	"Подумаю" исчезают, планы лечения не возвращаются	Камбэк	Модуль возврата
Хаос в CRM	Статусы не ведутся, нет отчётности, обращения теряются	Контроль	CRM-контур patient flow

04 / VISIBLE LOSSES

Признаки видимых потерь до звонка

Перед первым касанием менеджер не продаёт услуги. Он формирует гипотезу потерь по открытым digital-точкам клиники.

Карты

- рейтинг ниже 4.5 при сильной конкуренции рядом
- мало свежих отзывов
- нет ответов на негатив
- слабые фото клиники и врачей
- нет актуальных услуг и ссылок на запись

Сайт

- сайт не объясняет, почему выбрать клинику
- на мобильной версии сложно записаться
- не видно врачей, кейсов, гарантий и доказательств
- нет понятного следующего действия
- цены или услуги поданы без смысла

Отзывы и соцсети

- ответы шаблонные или отсутствуют
- нет работы со страхами пациента
- много постов без patient flow-логики
- нет связи с сайтом, записью и маршрутом пациента

Коммуникация

- мессенджеры спрятаны
- формы неудобны
- нет понятного телефона
- не видно онлайн-записи
- непонятно, кто и как отвечает пациенту

05 / SCORING

Скоринг клиента от 0 до 100

Скоринг нужен для приоритизации базы outbound. Он защищает продажи от мусорных лидов и показывает, на кого тратить время в первую очередь. Максимум - 100 баллов.

Критерий	Вес	Как ставить баллы
Размер и стадия	15	0-5: слишком малая; 6-10: есть поток, но слабая зрелость; 11-15: 2-8 кресел, стабильная работа, потенциал роста
Digital-точки	15	0-5: почти ничего нет; 6-10: есть сайт/карты/отзывы; 11-15: есть несколько точек и признаки вложений
Видимые потери	20	0-7: потери неочевидны; 8-14: есть 2-3 гипотезы; 15-20: видны серьёзные утечки patient flow
Платёжеспособность	15	0-5: эконом-сегмент; 6-10: средний сегмент; 11-15: клиника способна платить за систему
Доступ к ЛПР	10	0-3: ЛПР неясен; 4-7: есть управляющий; 8-10: виден собственник или директор
Готовность к системе	15	0-5: хочет разовые задачи; 6-10: готов к диагностике; 11-15: понимает роль процессов и данных
Потенциал LTV	10	0-3: разовая задача; 4-7: стартовый проект; 8-10: 90-дневные циклы и сопровождение

Баллы	Интерпретация	Действие
80-100	Приоритет А. Идеальный ICP	Готовить персональное касание и Patient Flow Check
60-79	Приоритет В. Перспективный клиент	Касаться после А-базы, усиливать гипотезу потерь
40-59	Приоритет С. Осторожно	Работать только при явной боли и доступе к ЛПР
0-39	Не приоритет	Не тратить outbound-ресурс

06 / RED FLAGS

Красные флаги

Красные флаги нужны для защиты фокуса. Плохой клиент съедает время, маржу и категорию.

- Нет бюджета или клиент сразу говорит: "нам бы подешевле".
- Запрос звучит как "нужен SMM", "сделайте сайт", "дайте заявки" без интереса к диагностике.
- Собственник или управляющий недоступен, общение только через администратора без полномочий.
- Клиника не готова давать доступы, цифры, данные CRM, записи звонков или информацию по обращениям.
- Клиент считает, что администраторы ни при чём, а вся проблема всегда только в рекламе.
- Требуют гарантию пациентов до диагностики patient flow.
- Нет сайта, карт, отзывов, администраторов или потока - нечего диагностировать и улучшать.
- Клиент хочет результат без участия клиники и без изменений внутри.
- Системно обесценивает работу: "а что тут сложного", "мы сами всё знаем".
- Постоянно меняет вводные, не фиксирует решения, не уважает регламент коммуникации.

Абсолютное правило

Если клиент не готов к диагностике, данным и изменениям процессов, он не покупает Patient Flow System. Его нельзя тянуть в 90-дневный цикл только ради выручки.

07 / QUALIFICATION

Квалификационные вопросы

Квалификация должна выяснить не "интересно ли им продвижение", а есть ли у клиники боль patient flow, деньги, ответственный ЛПР и готовность внедрять изменения.

Блок	Вопросы для звонка
Контекст	Сколько кресел? Какие направления основные? Кто отвечает за рост первичных пациентов?
Поток	Откуда сейчас приходят обращения? Сколько превращается в записи? Где чаще всего теряются люди?
Digital	Есть ли сайт, карты, реклама, CRM, мессенджеры? Что из этого работает стабильно?
Обработка	Кто отвечает на звонки и сообщения? Смотрите ли пропущенные, недозвоны, "подумаю"?
Решение	Кто принимает решение по бюджету и изменениям процессов? Готов ли собственник участвовать во встрече?

Блок	Вопросы для встречи / CRM
Цель	Что вы хотите получить через 3 месяца: больше записей, выше доходимость, возврат пациентов или контроль системы?
Потери	Где пациенты чаще всего пропадают: после сайта, звонка, сообщения, консультации или плана лечения?
Данные	Какие цифры вы смотрите каждую неделю? Где фиксируются обращения и статусы?
Готовность	Если диагностика покажет проблему в обработке или CRM, готовы менять процесс внутри клиники?
Бюджет	Готовы ли рассматривать не разовую услугу, а 90-дневный цикл управления patient flow?

08 / FIRST 300

Приоритетные клиенты для первых 300 контактов

Первые 300 контактов должны быть не случайной базой, а управляемым рыночным тестом. Цель - найти сегменты, где боль patient flow видна до звонка и быстро конвертируется в Patient Flow Check.

Приоритет	Кого брать	Почему
1	Частные клиники 2-8 кресел в конкурентных районах крупных городов	Есть спрос, конкуренция и потребность в управляемости patient flow
2	Клиники с рекламой и слабым путём после клика	Можно показать, что проблема не только в трафике
3	Клиники с хорошими врачами, но слабым сайтом или картами	Легко показать потери доверия и контекста выбора
4	Клиники с рейтингом 4.0-4.5 и слабой работой с отзывами	Видимая точка входа через карты и доверие
5	Клиники с CRM или онлайн-записью, но хаотичной коммуникацией	Можно продавать контур контроля и обработки

Города и районы: начинать с крупных городов и платёжеспособных районов, где стоматологии конкурируют за первичного пациента, а собственник уже понимает стоимость потока. Внутри города приоритет - районы с высокой плотностью частных стоматологий и заметной конкуренцией на картах.

09 / FORMULA

Формула идеального клиента

Идеальный клиент ШАРiK digital - частная стоматология с 2-8 креслами, у которой уже есть поток, сайт, карты, отзывы, администраторы и digital-активность, но нет ясности, где пациенты теряются до записи, лечения и возврата.

Собственник готов смотреть на patient flow как на систему, давать данные, менять процессы и платить за управляемость, а не за отдельные дешёвые задачи.

Формула для outbound

Мы выбираем клиники, где видны признаки patient flow-потерь: пациент может найти клинику, но не доверит ей выбор, не дойти до записи, потеряться в обработке или не вернуться. С такими клиниками мы начинаем не с предложения услуг, а с Patient Flow Check.

Как использовать документ

- В продажах - как фильтр, кого брать в работу и как формулировать первый заход.
- В CRM - как скоринговую модель и критерии квалификации.
- В outbound - как стандарт отбора базы и подготовки гипотез потерь.
- В найме продажника - как объяснение, что мы не продаём "продвижение", а ищем клиники с управленческой болью patient flow.
- В стратегии - как защита от расползания в любую нишу и любые запросы.

10 / CHECKLIST

Чек-лист решения: брать или не брать

Вопрос	Да / Нет
Клиника частная и работает в стоматологии?	
Есть 2-8 кресел или сопоставимый масштаб?	
Есть сайт, карты, отзывы или другие digital-точки?	
Видны 2-3 гипотезы patient flow-потерь до звонка?	
Есть признаки платёжеспособности?	
Можно выйти на собственника или управляющего?	
Клиника уже получает обращения или вкладывается в digital?	
Проблема не сводится к "нужен SMM подешевле"?	
Клиент готов обсуждать обработку, CRM, администраторов и данные?	
Есть потенциал продажи Карты потерь, стартового проекта или 90-дневного цикла?	

Брать в первую очередь

80+ баллов по скорингу, видимые потери, доступ к ЛПР, готовность к диагностике и системному разговору.

Не трогать

0-39 баллов, нет бюджета, нет данных, нет ЛПР, нет потока, запрос только на дешёвые задачи без диагностики.

Финальный стандарт

ICP считается внедрённым, если менеджер не добавляет клинику в активную outbound-базу без скоринга, гипотезы потерь и понимания, кто принимает решение. ШАРИК digital растёт не через количество контактов, а через точность выбора клиентов.